가이드라인 준수 판정 워크플로 — 규칙이 판정하고, RAG는 근거와 예외를 맡는다

A 환자 1명 × 지침 1개 × 항목(선택 · 용량 · 시기)마다 판정한다



B 요법 비교 분기표 — 판정은 환자 단위 · 이분법이다 (예: 중증 CAP, MRSA · 녹농균 위험 없음 → S = ceftriaxone + azithromycin, A = levofloxacin)

R = S	준수 (추천) 예: ceftriaxone + azithromycin
R = A	준수 (대안) 예: levofloxacin 단독 · 알레르기 정보가 없어 증빙 없이 인정, 비율은 따로 보고
R ⊃ S (추천 + 추가 약제)	추가 약제가 다른 위험 행으로 설명되면 준수, 아니면 비준수 (과잉) 예: + vancomycin: MRSA 분리력 있으면 준수, 없으면 과잉
R ⊂ S (추천 중 일부만)	비준수 (누락) — 50%가 아니다 예: ceftriaxone 단독 (azithromycin 누락). 보조 지표로 구성요소 일치율만 따로
R ∩ S = ∅	비준수 (다른 약제) 예: cefepime + vancomycin (위험인자 없음)
R 없음 · 수술 예방 cefazolin 단독 · 바이러스 동반	해당 없음 (분모 제외, 수만 보고) 예: cefazolin 단독 310명
조건에 '모름'이 있고 후보 행 결론이 다름	판정 불가 (분모 제외, 하한선에서는 비준수) 예: vital 없어 중증도 미확정 (약 29%)
비준수인데 카드에 사유가 있음	정당한 이탈 (임상의 · LLM이 근거 제시한 것만) 예: 녹농균 분리력으로 cefepime 선택

C 미리 정해 둔 처리 규칙

- **카드 변수가 지침에 없다 (젖산, CRP 등)** → 판정에 안 쓴다. 보고서의 맥락으로만 준다
- **지침 조건이 카드에 없다 (알레르기, 영상 다엽 침윤)** → '모름'으로 둔다. 대안 요법은 증빙 없이 준수(대안)로 인정
- **항생제 2개 중 1개만 지침에 있다** → 환자 단위 비준수(누락). 약제 단위 50%로 세지 않는다
- **추천보다 넓게 썼다** → 위험인자가 카드에 있으면 준수, 없으면 비준수(과잉)
- **국내 · 해외 지침 결론이 다르다** → 각각 판정해 둘 다 보고. 규칙표의 relation(common / conflict)
- **용량 · 경로 · 시기** → 선택과 분리해 따로 집계. mg/kg 약제는 체중 없으면 판정 불가
- **지침이 다루지 않는 환자 (예방적 투여, 바이러스 폐렴 동반)** → 해당 없음. 수를 보고하고 분모에서 뺀다
- **판정 불가가 많다** → 분모에서 빼되, 비준수로 본 하한선 준수율을 같이 낸다
- **LLM 판정이 규칙과 다르다** → 표본에서만 비교. 준수율은 규칙으로만 계산한다

준수율(선택) = (준수 추천 + 준수 대안) ÷ (전체 − 해당 없음 − 판정 불가) · 함께 보고: 해당 없음 n, 판정 불가 n, 비준수 유형별 n, 대안 비율, 하한선